LAPORAN TUGAS TERSTRUKTUR

Anggota Kelompok : Niha Nuraeni 2507042

Ajeng Mir'at Aunillah 2507051

Khillah Nurazizah 2507037

Implementasi Sistem Informasi Klinik Terintegrasi (Klinik Sehat Bersama)

1. **Profil Singkat Organisasi & Proses Kerja Utama**
    1. **Nama Organisasi:** Klinik Sehat Bersama.
    2. **Profil Kasus:** Merupakan klinik kesehatan swasta yang melayani pemeriksaan umum, konsultasi dokter, tindakan medis, dan pelayanan obat. Saat ini sebagian proses masih manual dan belum terintegrasi, menyebabkan pelayanan lambat, antrean menumpuk, pencarian rekam medis memakan waktu, serta pembuatan laporan terpisah-pisah. Manajemen berencana mengembangkan **Sistem Informasi Klinik Terintegrasi**.
    3. **Proses Kerja Utama:**
        1. **Pendaftaran Pasien:** Registrasi pasien baru/lama dan pembuatan antrean.
        2. **Pemeriksaan & Tindakan Medis:** Pencatatan keluhan/tanda vital oleh perawat, pemeriksaan & penegakan diagnosis oleh dokter, serta perekaman rekam medis.
        3. **Pelayanan Farmasi:** Penerimaan resep elektronik, penyiapan obat, dan pembaruan stok obat.
        4. **Pembayaran & Kasir:** Penghitungan total biaya layanan/tindakan/obat dan pencetakan bukti bayar.
        5. **Pelaporan Manajemen:** Rekapitulasi transaksi keuangan, riwayat kunjungan, dan performa operasional untuk manajemen.
2. **Tabel Analisis Stakeholder (Skala Power–Interest 1–5 & Strategi)**

    Skala yang digunakan sesuai modul:
    - **Power (1–5):** Otoritas/kekuatan memengaruhi jalannya keputusan proyek (1 = Sangat Rendah s.d. 5 = Sangat Tinggi).
    - **Interest (1–5):** Tingkat kepedulian/kebutuhan terhadap keberhasilan proyek (1 = Sangat Rendah s.d. 5 = Sangat Tinggi).

NO	Stakeholder	Power	Interest	Alasan/Argumentasi Nilai	Strategi Pengelolaan dan komunikasi
1	Pemilik Klinik (Owner)	5	4	Pemilik memegang kendali finansial tertinggi dan arah bisnis klinik, namun tidak terlibat harian dalam operasional teknis.	Manage Closely / Keep Satisfied: Libatkan dalam penetapan target bisnis utama, berikan update milestone, dan laporan kelayakan anggaran.
2	Kepala Klinik	5	5	Pemimpin proyek langsung, penentu integrasi alur kerja, pengambil keputusan kebijakan operasional harian, dan sangat bergantung pada sistem untuk laporan manajerial	Manage Closely: Koordinasi intensif mingguan, pengambilan keputusan fitur, serta review kesiapan tim sebelum implementasi
3	Divisi IT Klinik	4	5	Bertanggung jawab langsung atas infrastruktur, keamanan data pasien, integrasi, dan pemeliharaan jangka panjang.	Manage Closely: Rapat teknis berkala, koordinasi harian dengan vendor, dan pengujian sistem
4	Vendor Pengembang	4	3	Memiliki kekuatan teknis untuk membangun sistem, namun memiliki batasan kontrak/waktu dan menangani proyek lain	Keep Satisfied: Penyusunan SLA dan kontrak yang jelas, monitoring jadwal rilis, serta menjaga komunikasi profesional
5	Dokter	3	4	Memiliki pengaruh fungsional penting pada adopsi modul rekam medis; sangat peduli pada kecepatan pencarian riwayat dan input hasil medis.	Keep Informed: Dilibatkan dalam perancangan tampilan rekam medis (UI/UX), pelatihan khusus dokter, dan penampungan masukan berkala.
6	Apoteker / Bagian Farmasi	2	5	Tidak memiliki wewenang penentu proyek, namun sangat bergantung pada akurasi resep digital dan pembaruan stok obat realtime.	Keep Informed: Diberikan simulasi peresepan, pelatihan stok opname pada sistem, dan saluran pengaduan kendala teknis
7	Petugas Pendaftaran & Kasir	2	4	Pengguna ujung tombak (frontliner) yang membutuhkan kecepatan proses antrean dan akurasi pembayaran, namun wewenang keputusannya rendah	Keep Informed: Pelatihan intensif alur pendaftaran/kasir, panduan penggunaan (SOP), serta evaluasi antrean.
8	Perawat	2	4	Pelaksana pencatatan tanda vital dan tindakan medis harian; terdampak langsung oleh perubahan dari manual ke digital	Keep Informed: Pendampingan saat transisi sistem (hands-on training) dan sesi tanya jawab kendala.
9	Pasien	1	3	Pengguna akhir layanan; tidak punya kendali terhadap proyek internal, tetapi ingin waktu tunggu lebih singkat dan data akurat.	Monitor with Minimum Effort: Pemantauan kepuasan pasien melalui survei berkala dan sosialisasi alur baru klinik

3. **Pengelompokan Kuadran Power–Interest Grid**
   Berdasarkan titik potong sumbu (Power > 3 dianggap Tinggi, Interest > 3 dianggap Tinggi):
   1. **High Power – High Interest (Kelola Secara Dekat / *Manage Closely*):**
      - **Kepala Klinik** (5, 5)
      - **Pemilik Klinik** (5, 4)
      - **Divisi IT** (4, 5)
      - *Alasan:* Mereka adalah penentu utama keberhasilan proyek, pemegang anggaran, pembuat kebijakan, dan pengendali teknis implementasi.
   2. **High Power – Low/Medium Interest (Jaga Kepuasannya / *Keep Satisfied*):**
      - **Vendor Pengembang** (4, 3)
      - *Alasan:* Memegang kendali atas kode program dan waktu penyelesaian, namun kepentingannya dibatasi oleh klausul kontrak proyek. Harus dijaga agar tetap berkomitmen sesuai jadwal dan anggaran.
   3. **Low Power – High Interest (Dilibatkan Melalui Komunikasi Rutin / *Keep Informed*):**
      - **Dokter** (3, 4)
      - **Apoteker** (2, 5)
      - **Petugas Pendaftaran & Kasir** (2, 4)
      - **Perawat** (2, 4)
      - *Alasan:* Mereka adalah pengguna harian (*end-users*). Jika mereka menolak atau kesulitan menggunakan sistem, implementasi akan gagal. Perlu pelatihan, panduan jelas, dan umpan balik berkala.

4. **Low Power – Low Interest (Cukup Dimonitor / *Monitor with Minimum Effort*):**
    - **Pasien** (1, 3)
    - *Alasan:* Pasien tidak menentukan arsitektur sistem maupun operasional internal klinik. Cukup dipantau kepuasannya terhadap dampak sistem baru (misal: waktu antrean berkurang).

